



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究

**A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images**

研究生：張博翔

指導教授：尤信程、劉建宏

中華民國一百一十五年七月



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：尤信程、劉建宏

中華民國一百一十五年七月

「學位論文口試委員會審定書」掃描檔

審定書填寫方式以系所規定為準，但檢附在電子論文內的掃描檔須具備以下條件：

1. 含指導教授、口試委員及系所主管的完整簽名。
2. 口試委員人數正確，碩士口試委員至少 3 人、博士口試委員至少 5 人。
3. 若此頁有論文題目，題目應和書背、封面、書名頁、摘要頁的題目相符。
4. 此頁有無浮水印皆可。

摘要

關鍵詞：胸部 CT、慢性阻塞性肺病、量化生物標記、Hybrid Mamba-Attention、TAP-CT、類別不平衡

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種與氣道阻塞、肺氣腫相關之慢性呼吸道疾病。臨床上雖以肺功能檢查作為主要診斷依據，胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）仍可提供肺實質、氣道、血管等結構性資訊，具備作為輔助診斷與疾病表徵分析之潛力。本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，並結合可解釋之影像量化生物標記與 3D 深度影像模型，探討 CT 影像於正異常分類與肺功能相關塌陷角度分級之應用可行性。

本研究首先針對 54 筆臨床胸部 CT 影像建立量化特徵分析流程，由 CT 影像產生肺葉、血管與氣道相關分割標籤，並擷取 12 項具臨床意義之量化生物標記，包括全肺與分葉肺氣腫比例、小血管體積比例、氣道壁比例、血管密度、氣道肺體積比例、總肺容積及肺動脈直徑。分類模型採用全連接神經網路，並以 stratified five-fold cross validation 評估 Normal/Abnormal 分類效能。實驗結果顯示，量化特徵模型可達 92.59% 之整體準確率、0.9355 之 F1-score 與 0.9784 之 AUC，顯示胸部 CT 量化生物標記可提供具可解釋性之 COPD 輔助判讀依據。

其次，本研究進一步使用 66 筆具肺功能相關標籤之 3D CT 影像，將原始影像輸入 Mamba、SwinUNETR 與 Hybrid Mamba-Attention 等模型，分別進行以 131° 與 152° 為門檻之塌陷角度（Angle of Collapse, AC）三分類，以及排除 132° 至 151° 區間的二分類。為降低小樣本與類別不平衡的偏差，本研究採用交叉驗證，並僅於訓練中進行資料增強與平衡取樣。結果顯示，結合預先萃取之 TAP-CT 影像嵌入後，AC 三分類可達 0.8209 之 accuracy、0.6141 之 Macro-F1 與 0.6326 之 balanced accuracy，極端二分類則可達 0.9192 之 accuracy、0.8763 之 Macro-F1 與 0.8778 之 balanced accuracy。整體而言，本研究結果顯示，胸部 CT 量化生物標記與 3D 深度影像模型具有互補性，可分別提供可解釋之結構量化依據與影像層級之肺功能表徵學習能力，並可作為 COPD 輔助診斷之參考。

ABSTRACT

Keyword: chest CT, COPD, quantitative biomarkers, Hybrid Mamba-Attention, TAP-CT, class imbalance

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory disease associated with airway obstruction and emphysema. Although pulmonary function testing remains the primary clinical basis for diagnosis, chest computed tomography (CT) provides structural information about lung parenchyma, airways, and vasculature, making it a potential source of auxiliary diagnostic evidence. This study develops a CT-based COPD auxiliary diagnostic framework that combines interpretable quantitative imaging biomarkers with 3D deep learning models, and evaluates its feasibility for Normal/Abnormal classification and pulmonary-function-related angle stratification.

For quantitative analysis, 54 clinical chest CT scans were processed to generate lobe, vessel, and airway label maps. Twelve clinically meaningful biomarkers were extracted, including emphysema percentages, small vessel volume ratio, airway wall ratio, vessel density, airway-to-lung volume ratio, total lung volume, and pulmonary artery diameter. A fully connected neural network with stratified five-fold cross-validation achieved 92.59% accuracy, an F1-score of 0.9355, and an AUC of 0.9784 for Normal/Abnormal classification, indicating that CT-derived biomarkers can provide interpretable evidence for COPD assessment.

For 3D image-based learning, 66 CT scans with pulmonary-function-related labels were evaluated using Mamba, SwinUNETR, and Hybrid Mamba-Attention models. The tasks included Angle of Collapse (AC) three-class classification using 131° and 152° as thresholds, and binary classification after excluding cases between 132° and 151° . With fused TAP-CT embeddings, AC three-class classification achieved 0.8209 accuracy, 0.6141 Macro-F1, and 0.6326 balanced accuracy, while binary classification achieved 0.9192 accuracy, 0.8763 Macro-F1, and 0.8778 balanced accuracy. Overall, CT-derived biomarkers and 3D models provide complementary evidence and may serve as references for COPD auxiliary diagnosis.

誌謝

所有對於研究提供協助之人或機構，作者都可在誌謝中表達感謝之意。



目錄

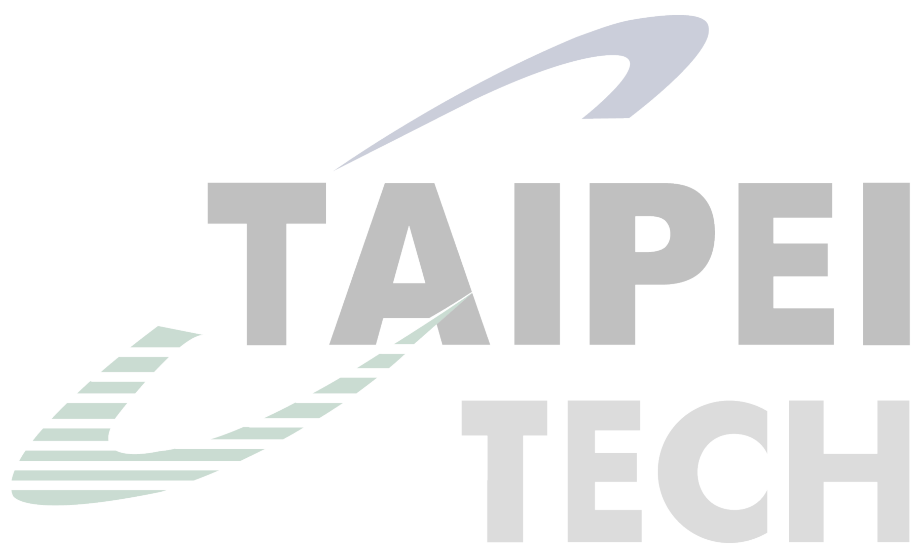
摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	2
1.3 論文架構	3
第二章 文獻回顧	4
2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查	4
2.2 CT 影像表徵與量化生物標記	5
2.3 肺部、氣道與血管影像分割	7
2.4 三維醫學影像深度學習模型	9
2.5 小樣本與類別不平衡問題	9
2.6 評估指標	9
第三章 研究材料與方法	10
3.1 整體研究流程	10
3.2 資料來源與標籤定義	10
3.3 CT 影像前處理	10
3.4 肺部結構分割與量化參數擷取	10
3.5 量化生物標記分類模型	10
3.6 三維 CT 深度學習模型	10
3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略	10
3.8 交叉驗證、資料增強與平衡取樣	10
3.9 評估方法	10

第四章	實驗結果與討論	11
4.1	實驗環境與資料集統計	11
4.2	CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果	11
4.3	三維 CT Normal/Abnormal 分類結果	11
4.4	PFT Angle Regression 結果	11
4.5	Angle 三分類結果	11
4.6	Extreme Binary Classification 結果	11
4.7	GOLD Stage 分類結果	11
4.8	綜合討論與限制	11
第五章	結論與未來展望	12
5.1	研究結論	12
5.2	研究貢獻	12
5.3	研究限制	12
5.4	未來工作	12
參考文獻		13

表目錄



圖目錄



第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是一種以持續性氣流受限為主要特徵之慢性呼吸道疾病，其病理變化常包含肺實質破壞、肺氣腫、氣道發炎、氣道重塑與肺部血管變化。COPD 進展通常具有長期性與不可完全逆轉之特性，若未能及早發現並追蹤，其肺功能下降、急性惡化與生活品質受損等問題將對病患照護造成持續負擔 [1]。因此，如何利用既有臨床影像資料提供客觀、可重複且可解釋之輔助資訊，是 COPD 研究與醫療決策支援中重要的課題。

临床上，COPD 之診斷與嚴重程度評估主要仰賴肺功能檢查。肺功能檢查能反映整體呼吸生理狀態，並提供氣流受限程度之量化依據 [1]。然而，肺功能檢查較難直接呈現肺部結構異常之位置、範圍與型態；相同肺功能表現之病患，在肺氣腫分布、氣道壁變化、肺過度充氣與血管結構改變上仍可能存在差異。若僅依賴單一生理測量結果，可能不足以完整描述 COPD 的影像表型 [2]。

胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）具有高空間解析度，可呈現肺實質、氣道、血管與肺葉分布等解剖資訊。透過 CT 影像，可觀察低衰減區域所對應之肺氣腫變化、肺容積增加所反映之過度充氣現象，以及氣道與血管相關結構特徵。若能將 CT 影像進一步轉換為可量化之影像生物標記，便可使影像分析由主觀判讀延伸至數值化描述，並提供 COPD 輔助診斷與後續追蹤之參考 [2]。

近年醫學影像分析逐漸結合自動分割、量化特徵擷取與深度學習模型。對於 COPD CT 影像而言，自動化流程可先由肺葉、氣道與血管等結構分割開始，再計算肺氣腫比例、肺容積、氣道相關比例與血管相關指標等特徵；此類特徵具有較高可解釋性，能與 COPD 病理變化相互對應 [2]。另一方面，三維深度影像模型可直接由 CT 體積資料學習空間表徵，補足人工定義特徵可能無法涵蓋之影像訊息 [3, 4]。兩類方法各有優勢：量化特徵方法較容易解釋，深度影像模型則具備自動特徵學習能力。

然而，實際醫學影像研究常受限於資料量不足、掃描協議不一致、分割品質差異與類別分布不均等問題。若模型評估僅呈現整體準確率，容易忽略資料不平衡造成的偏差，也可能掩蓋異常個案漏判等临床上更需關注的問題 [5]。因此，本研究以胸部 CT

影像為核心，建立 COPD 輔助診斷之自動化分析流程，並以可解釋量化特徵與三維影像模型進行比較，探討兩者在小樣本資料下應用於 Normal/Abnormal 分類、塌陷角分級與 GOLD 分級等 COPD 相關輔助判讀任務之可行性。

1.2 研究目的

本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，將影像資料轉換為具臨床意義之量化資訊，並評估不同影像分析策略於分類任務中之表現。研究目的分述如下。

首先，本研究建置胸部 CT 影像前處理與肺部結構分割流程，將原始影像轉換為後續量化分析可使用之資料格式，並擷取肺葉、氣道與血管等結構資訊。透過自動化流程，可降低人工處理成本，並提高多筆影像資料分析之一致性。

其次，本研究依據 COPD 相關影像表徵擷取 CT 量化生物標記，包括全肺與各肺葉肺氣腫比例、肺容積、氣道相關比例、血管密度、小血管體積比例與肺動脈相關指標等特徵。此類特徵可對應肺實質破壞、過度充氣、氣道重塑與血管變化等 COPD 相關結構異常，作為可解釋分類模型之輸入 [2]。

第三，本研究使用量化生物標記建立 Normal/Abnormal 分類模型，評估其區分正常與異常胸部 CT 個案之能力。模型評估採用交叉驗證，並搭配 accuracy、precision、recall、F1-score、AUC 與混淆矩陣等指標，以觀察模型整體表現及錯誤分類型態。

第四，本研究使用三維 CT 深度學習模型分析原始影像資料，評估其於 COPD 相關影像分類與肺功能相關分級任務中之可行性。此部分聚焦於分類與分級任務，包含 Normal/Abnormal 分類、塌陷角分級、排除中間灰區後之極端二分類，以及 GOLD 分級分類，並與量化特徵方法進行比較。

最後，本研究針對小樣本與類別不平衡問題，探討資料分割、資料增強、平衡取樣與多指標評估對結果解讀之影響，避免以單一指標過度推論模型效能，並使研究結果維持於臨床輔助判讀與方法可行性評估之定位。

1.3 論文架構

本論文共分為五章。第一章說明研究背景與動機、研究目的及論文架構。第二章整理 COPD 臨床背景、胸部 CT 影像分析、肺部結構分割、CT 量化生物標記、三維醫學影像模型與小樣本類別不平衡問題之相關研究。第三章說明研究材料與方法，包含資料來源、影像前處理、肺部結構分割、量化參數擷取、分類模型、三維影像模型、塌陷角與 GOLD 相關分類標籤，以及評估方法。第四章呈現實驗結果與討論，包含 CT 量化特徵分類結果、三維 CT 影像模型分類與分級結果、錯誤案例分析與綜合討論。第五章總結本研究成果，並提出後續於資料擴充、分割品質改善、模型泛化驗證與臨床應用評估之未來方向。



第二章 文獻回顧

2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是一種常見且具有異質性的慢性呼吸道疾病，其核心特徵為持續性呼吸道症狀與氣流受限。COPD 的病理變化通常涉及小氣道發炎與重塑、氣道狹窄、肺實質破壞、肺氣腫與氣體滯留等現象，因此病患可能出現慢性咳嗽、咳痰、活動性喘促與運動耐受度下降等臨床表現。由於 COPD 之疾病進展具有長期性，且肺功能下降後不易完全恢復，臨床上需透過客觀檢查評估氣流受限程度與疾病嚴重度 [1]。

肺功能檢查（Pulmonary Function Test, PFT）是 COPD 診斷與嚴重程度評估中最重要之生理測量工具，其中又以肺量計測定（spirometry）最常用。肺量計測定可量測用力肺活量（Forced Vital Capacity, FVC）、一秒用力呼氣容積（Forced Expiratory Volume in one second, FEV1）與 FEV1/FVC 比值。FVC 代表受測者深吸氣後以最大力量呼出的總氣體量；FEV1 則代表用力呼氣第一秒內排出的氣體量；FEV1/FVC 比值可反映第一秒呼出量相對於總用力肺活量的比例，因此常用於判斷是否存在氣流受限。依 GOLD 指引，支氣管擴張劑後 FEV1/FVC 小於 0.70 為確認持續性氣流受限的重要判準之一 [1]。

除 FEV1、FVC 與 FEV1/FVC 外，肺功能檢查亦可包含中段用力呼氣流速（Forced Expiratory Flow between 25% and 75% of FVC, FEF25–75%）、尖峰呼氣流速（Peak Expiratory Flow, PEF）、肺活量（Vital Capacity, VC）、肺總量（Total Lung Capacity, TLC）與肺餘容積（Residual Volume, RV）等指標。這些指標可從不同角度反映呼氣流速、肺容量與氣體滯留情形。例如 FEF25–75% 常被用於觀察中小氣道功能，RV 增加則可能與氣體滯留有關。雖然上述指標能提供更完整的呼吸生理資訊，但 COPD 嚴重度分級與本研究後續標籤設計主要仍以 FEV1 及其預測值百分比為核心。

在已確認氣流受限的情況下，GOLD 分級通常依支氣管擴張劑後 FEV1 佔預測值百分比（FEV1 percent predicted）區分氣流受限嚴重程度。FEV1 預測值會依年齡、身高、性別等生理條件估計，再以實測 FEV1 除以預測值取得百分比。GOLD 1 為 FEV1 大於或等於 80% 預測值，代表輕度氣流受限；GOLD 2 為 50% 至未滿 80%，代表中度氣流受限；GOLD 3 為 30% 至未滿 50%，代表重度氣流受限；GOLD 4 則為低於 30%，代表

極重度氣流受限 [1]。此分級方式可將連續的肺功能數值轉換為具臨床意義的嚴重度類別，因此常作為 COPD 相關研究中的標籤依據。

然而，肺功能檢查主要反映整體呼吸生理狀態，較難直接指出肺部結構異常的位置、型態與分布。同樣的 FEV1 或 GOLD 分級可能對應不同程度的肺氣腫、氣道壁增厚、過度充氣或血管改變，因此單一肺功能指標未必能完整描述 COPD 的影像表型 [2]。基於此限制，本研究後續將 PFT 相關資訊視為重要參考標籤，並結合胸部 CT 影像之量化特徵與三維影像模型，探討影像資訊對 COPD 輔助判讀與肺功能相關表徵預測之補充價值。

需要注意的是，本研究部分實驗使用資料集中支氣管擴張劑後 FEV1 佔預測值百分比建立 GOLD 相關分類標籤。由於正式 COPD 診斷與 GOLD 氣流受限分級仍需整合 FEV1/FVC 判準、症狀、病史與臨床判讀，因此本文在結果詮釋上將其視為肺功能導向之嚴重度候選標籤，而不直接等同完整臨床診斷或臨床分期。

2.2 CT 影像表徵與量化生物標記

胸部電腦斷層影像具有高空間解析度，可呈現肺實質、氣道、血管與肺葉分布等解剖結構，因此常被用於補充肺功能檢查無法直接呈現的局部結構資訊。對 COPD 而言，CT 影像中常見的結構性表徵包含肺氣腫造成的低衰減區域、肺過度充氣所反映的肺容積增加、氣道壁增厚或氣道狹窄，以及肺血管床減少或肺動脈相關變化等。這些影像表徵可對應 COPD 中肺實質破壞、小氣道病變與血管重塑等病理變化，因此 CT 不僅可作為視覺判讀工具，也可作為影像量化分析的資料來源 [6, 2]。

肺氣腫是 COPD 在 CT 影像中最常被量化的表徵之一。肺氣腫區域因肺泡壁破壞與氣腔擴大而呈現較低密度，因此在吸氣相 CT 中常以低衰減區域比例描述其範圍。常見作法是在肺部遮罩內計算低於特定 Hounsfield unit 閾值的 voxel 比例，例如低於 -950 HU 的低衰減區比例可作為肺氣腫負荷之指標。Gevenois 等人比較 HRCT 密度與肺組織巨觀形態量測後指出，-950 HU 閾值與巨觀肺氣腫量測具良好對應，因此此閾值常作為定量肺氣腫分析的依據之一 [7]。此類指標可進一步依肺葉計算，以呈現肺氣腫分布是否集中於特定肺葉或呈現不均勻分布。相較於僅以整體肺功能數值描述病患狀態，肺葉別肺氣腫比例能提供更具有位置資訊的影像表型描述。

肺容積與過度充氣亦是 COPD 影像評估中的重要概念。COPD 患者因氣流受限與呼氣不完全，可能產生氣體滯留與肺過度充氣，使總肺體積或特定肺葉體積出現改變。CT 影像若經過肺部或肺葉分割，便可依 voxel spacing 計算實際體積，將肺部形態由視覺印象轉換為可比較的數值。Bakker 等人回顧 quantitative CT 與肺功能檢查之關係時指出，CT 可萃取 residual volume、total lung capacity 等肺容積資訊，且此類 CT-derived lung volume 與 PFT 量測之肺容積具有相關性，特別適合用於描述 COPD 的過度充氣相關表徵 [8]。此類體積特徵雖可能受吸氣程度、體型差異與掃描範圍影響，但仍可作為描述 COPD 影像表徵的重要補充資訊。

除肺實質外，COPD 亦會影響氣道結構。慢性發炎與氣道重塑可能造成氣道壁增厚、氣道腔狹窄與小氣道阻塞。CT 量化分析中常見的氣道相關指標包含氣道壁比例 (wall area percentage, WA%)、氣道體積與肺體積之比例，以及由氣道遮罩推估的相關形態特徵。既有研究指出，WA% 是 COPD 吸菸族群中常用的中央氣道形態量測指標，且與 FEV1 預測值百分比具有相關性；系統性回顧亦顯示 WA%、wall thickness、Pi10 與 luminal area 等 CT 氣道參數已被廣泛用於 COPD 與相關呼吸疾病研究 [9, 10]。理想情況下，WA% 需根據氣道腔與氣道壁的可靠分割結果計算；若缺乏完整的 lumen 與 wall 標註，則只能以可取得之氣道遮罩或氣管標籤進行近似估計。因此，在使用氣道量化指標時，必須同時說明分割來源與計算限制，避免將自動估計結果過度解釋為精確的小氣道壁厚量測。

肺血管變化也是 COPD 影像分析中逐漸受到重視的面向。肺氣腫造成肺泡壁與微血管床破壞，可能使血管密度下降；另一方面，COPD 亦可能伴隨肺血管重塑與肺動脈壓力相關變化。Matsuoka 等人以 CT 量測小肺血管橫截面積，發現小血管面積比例與肺氣腫比例及肺功能指標相關，顯示肺血管量化可提供肺實質破壞以外的補充資訊 [11]。因此，CT 影像中可由血管分割結果計算總血管體積、血管密度、小血管體積比例 (small vessel volume percentage, SVV%) 與肺動脈直徑等指標。血管密度通常可定義為分割血管體積相對於總肺體積之比例；SVV% 則可透過血管遮罩與距離轉換等方式估計小血管負荷。肺動脈與主動脈直徑比例 (PA:A ratio) 亦常被視為肺血管與肺高壓相關的影像指標；Wells 等人曾以 CT 上肺動脈與主動脈直徑比例大於 1 作為肺動脈擴大指標，並探討其與 COPD 急性惡化之關係 [12]。然而，若缺乏可靠主動脈分割或標準化人工量測流程，則不宜將 PA:A ratio 列為已完成之自動量化結果。

綜合而言，CT 量化生物標記的價值在於將 COPD 相關影像表徵轉換為客觀、可重複且可供模型分析的數值。本研究採用之 CT 特徵並非任意挑選，而是依據既有 COPD quantitative CT 文獻中常見且具病理對應之影像表徵整理而成：肺氣腫比例可反映肺實質破壞，肺容積可描述過度充氣與形態差異，氣道指標可對應氣道重塑，血管指標則補充肺血管床與肺動脈相關資訊。這些特徵具有較高可解釋性，適合用於小樣本資料下的傳統機器學習或神經網路分類模型。然而，CT 量化結果仍會受到掃描協議、重建參數、吸氣程度、分割品質與指標定義差異影響，因此後續方法章需明確說明各項特徵之輸入、公式與限制。

2.3 肺部、氣道與血管影像分割

胸部 CT 影像雖可呈現肺實質、氣道與血管等細部解剖結構，但若未先界定各結構所在區域，影像灰階值與體積資訊便難以轉換為具生理意義的量化特徵。因此，在 COPD 相關 CT 分析中，影像分割通常扮演兩項關鍵角色：其一為建立特徵計算的解剖區域，例如以肺部或肺葉遮罩限定肺氣腫比例與肺容積之計算範圍；其二為提供可解釋的結構標籤，使氣道與血管相關指標能對應至特定病理變化。若分割邊界錯誤、末端管狀結構漏失，或將非目標組織誤判為目標結構，後續低衰減區比例、血管密度、小血管體積比例與氣道相關特徵皆可能受到影響。因此，影像分割並非單純的前處理程序，而是 quantitative CT 分析可信度的重要基礎。

深度學習已成為醫學影像分割的重要方法。Litjens 等人回顧深度學習於醫學影像分析之應用時指出，卷積神經網路已廣泛應用於影像分類、偵測與分割等任務 [3]。其中，U-Net 透過 encoder-decoder 結構與 skip connection 保留局部空間資訊，奠定了許多生物醫學影像分割模型的基礎 [13]。針對三維醫學影像分割，nnU-Net 進一步提出自動化設定策略，依資料特性調整前處理、網路架構與訓練流程，降低不同任務間人工調參的需求 [14]。在研究與實作工具方面，3D Slicer 可支援醫學影像讀取、分割、三維視覺化與量測 [15]；MONAI 則提供以 PyTorch 為基礎的醫學影像深度學習框架，整合資料轉換、模型訓練與推論流程 [16]。

肺部與肺葉分割是 COPD 量化 CT 分析中最基礎的結構分割任務。Hofmanninger 等人針對例行性胸部影像之肺部分割進行研究，指出模型表現高度受到資料多樣性

影響，臨床應用時需面對不同掃描協議、疾病型態與影像品質所造成的變異 [17]。TotalSegmentator 則建立可分割多種 CT 解剖結構的自動化工具，顯示多器官與多結構 label map 已逐漸成為 CT 影像量化研究的重要基礎 [18]。針對肺氣腫量化，Li 等人提出 EmphysemaSeg，結合自動肺葉分割與肺氣腫評估，用於低劑量肺癌篩檢 CT 中的肺葉別肺氣腫量化 [19]。上述研究說明，肺部與肺葉分割不僅用於排除非肺部組織，也會直接影響肺氣腫比例、肺葉體積與疾病分布型態之估計。

氣道分割相較於肺部遮罩更具挑戰性，原因在於氣道樹具有細長、多分支、末端管徑小且與肺血管相鄰等特性，分割時容易出現末端分支中斷、管腔漏失或誤判其他低密度結構等問題。Garcia-Uceda 等人提出以 3D convolutional neural networks 為基礎的自動氣道分割方法，並在胸部 CT 資料中驗證其對氣道樹萃取的可行性 [20]。AeroPath 則建立含有肺氣腫、腫瘤等病理變化之氣道分割 benchmark，強調胸部病理變化會增加氣道分割困難度，並提供評估模型於複雜臨床影像中穩健性的資料與基準方法 [21]。然而，COPD 氣道量化若要進一步估計 WA% 或氣道壁厚，通常需要可靠的 airway lumen 與 wall 資訊；若僅取得氣道樹遮罩或氣管標籤，則較適合作為 airway-derived features，而不宜直接視為精確的小氣道壁厚量測。

血管分割則與 COPD 影像中肺血管床減少、小血管比例改變與肺動脈相關指標有關。Matsuoka 等人以 CT 量測小肺血管橫截面積，顯示小血管量化與肺氣腫比例及氣流受限具有關聯 [11]。在自動分割方法上，肺血管與氣道皆屬細長管狀結構，相對於背景 voxel 數量極少，容易形成類別不平衡與末端分支漏失問題。Qin 等人提出 tubule-sensitive CNN，用於肺部氣道與肺動靜脈分割，並針對管狀結構在 CT 中比例小、形態細長與分支複雜等問題設計模型策略 [22]。因此，血管密度、SVV% 與肺動脈相關指標雖可提供 COPD 血管表型資訊，但其可靠性仍取決於血管分割對主幹血管與末端小血管的偵測能力。

綜合上述文獻，肺部、肺葉、氣道與血管分割分別支撐 COPD quantitative CT 中不同類型的影像生物標記：肺部與肺葉分割影響肺容積與肺氣腫比例，氣道分割影響 airway-derived features，血管分割則影響血管密度、小血管比例與肺動脈相關估計。既有研究已提供多種可用的深度學習模型、公開工具與 benchmark，但各方法在標籤定義、輸出格式、資料來源與疾病情境上並不完全一致。因此，在後續方法章中，需明確說明實際採用之分割來源、輸出標籤、特徵計算方式與限制，避免將不同來源之分

割結果視為完全等價。

2.4 三維醫學影像深度學習模型

2.5 小樣本與類別不平衡問題

2.6 評估指標



第三章 研究材料與方法

3.1 整體研究流程

3.2 資料來源與標籤定義

3.3 CT 影像前處理

3.4 肺部結構分割與量化參數擷取

3.5 量化生物標記分類模型

3.6 三維 CT 深度學習模型

3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略

3.8 交叉驗證、資料增強與平衡取樣

3.9 評估方法

第四章 實驗結果與討論

4.1 實驗環境與資料集統計

4.2 CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果

4.3 三維 CT Normal/Abnormal 分類結果

4.4 PFT Angle Regression 結果

4.5 Angle 三分類結果

4.6 Extreme Binary Classification 結果

4.7 GOLD Stage 分類結果

4.8 綜合討論與限制

第五章 結論與未來展望

5.1 研究結論

5.2 研究貢獻

5.3 研究限制

5.4 未來工作



參考文獻

- [1] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. *Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: 2025 Report*. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2025. URL: <https://goldcopd.org/2025-gold-report/>.
- [2] Sohee Park et al. “Quantitative CT imaging in chronic obstructive pulmonary disease”. In: *British Journal of Radiology* (2025). DOI: 10.1093/bjr/tqaf105.
- [3] Geert Litjens et al. “A survey on deep learning in medical image analysis”. In: *Medical Image Analysis* 42 (2017). DOI: 10.1016/j.media.2017.07.005.
- [4] Hyunjung Park et al. “Deep Learning-based Approach to Predict Pulmonary Function at Chest CT”. In: *Radiology* 307.2 (2023). DOI: 10.1148/radiol.221488.
- [5] Haibo He and Eduardo A. Garcia. “Learning from Imbalanced Data”. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 21.9 (2009). DOI: 10.1109/TKDE.2008.239.
- [6] Shin Matsuoka et al. “Quantitative CT assessment of chronic obstructive pulmonary disease”. In: *Radiographics* 30.1 (2010). DOI: 10.1148/rg.301095110.
- [7] Pierre A. Gevenois et al. “Comparison of computed density and macroscopic morphometry in pulmonary emphysema”. In: *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 152.2 (1995). DOI: 10.1164/ajrccm.152.2.7633722.
- [8] Jens T. Bakker et al. “Measuring pulmonary function in COPD using quantitative chest computed tomography analysis”. In: *European Respiratory Review* 30.161 (2021). DOI: 10.1183/16000617.0031-2021.
- [9] George R. Washko et al. “Computed tomographic measures of airway morphology in smokers and never-smoking normals”. In: *Journal of Applied Physiology* 116.6 (2014). DOI: 10.1152/japplphysiol.00004.2013.
- [10] Ivan Dudurych et al. “Bronchial wall parameters on CT in healthy never-smoking, smoking, COPD, and asthma populations: a systematic review and meta-analysis”. In: *European Radiology* 32 (2022). DOI: 10.1007/s00330-022-08600-1.
- [11] Shin Matsuoka et al. “Quantitative CT measurement of cross-sectional area of small pulmonary vessel in COPD: correlations with emphysema and airflow limitation”. In: *Academic Radiology* 17.1 (2010). DOI: 10.1016/j.acra.2009.07.022.
- [12] J. Michael Wells et al. “Pulmonary arterial enlargement and acute exacerbations of COPD”. In: *New England Journal of Medicine* 367.10 (2012). DOI: 10.1056/NEJMoa1203830.

- [13] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation”. In: *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Vol. 9351. Lecture Notes in Computer Science. 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.
- [14] Fabian Isensee et al. “nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation”. In: *Nature Methods* 18.2 (2021). DOI: 10.1038/s41592-020-01008-z.
- [15] Andriy Fedorov et al. “3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network”. In: *Magnetic Resonance Imaging* 30.9 (2012). DOI: 10.1016/j.mri.2012.05.001.
- [16] M. Jorge Cardoso et al. “MONAI: An open-source framework for deep learning in health-care”. In: *arXiv preprint arXiv:2211.02701* (2022). DOI: 10.48550/arXiv.2211.02701.
- [17] Johannes Hofmanninger et al. “Automatic lung segmentation in routine imaging is primarily a data diversity problem, not a methodology problem”. In: *European Radiology Experimental* 4.1 (2020). DOI: 10.1186/s41747-020-00173-2.
- [18] Jakob Wasserthal et al. “TotalSegmentator: Robust Segmentation of 104 Anatomic Structures in CT Images”. In: *Radiology: Artificial Intelligence* 5.5 (2023). DOI: 10.1148/ryai.230024.
- [19] Thomas Z. Li et al. “Quantifying emphysema in lung screening computed tomography with robust automated lobe segmentation”. In: *Journal of Medical Imaging* 10.4 (2023). DOI: 10.1117/1.JMI.10.4.044002.
- [20] Antonio Garcia-Uceda et al. “Automatic airway segmentation from computed tomography using robust and efficient 3-D convolutional neural networks”. In: *Scientific Reports* 11 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-95364-1.
- [21] Karen-Helene Støverud et al. “AeroPath: An airway segmentation benchmark dataset with challenging pathology and baseline method”. In: *PLOS ONE* 19.10 (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0311416.
- [22] Yulei Qin et al. “Learning Tubule-Sensitive CNNs for Pulmonary Airway and Artery-Vein Segmentation in CT”. In: *IEEE Transactions on Medical Imaging* 40.6 (2021). DOI: 10.1109/TMI.2021.3062280.